Valoración del dolor

Aspectos generales del manejo y control del dolor

tech

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Introducción
3. Entrevista clínica para la valoración del dolor
4. Métodos subjetivos para la valoración del dolor
5. Valoración basada en parámetros fisiológicos
6. Aspectos multidisciplinares de la valoración del dolor
7. Bibliografía

Objetivos

- Dar a conocer la metodología y objetivos de la entrevista clínica del paciente.
- Presentar los diferentes métodos de objetivación del dolor y sus aplicaciones clínicas.
- Mostrar herramientas disponibles para la valoración de aspectos psicológicos y emocionales del dolor.

Introducción

La valoración del dolor es un aspecto esencial para lograr un abordaje terapéutico ajustado al dolor que el paciente padece. Sin embargo, es una de las labores más complejas a realizar en el ámbito del manejo del dolor.

El dolor es, como su propia definición implica, una percepción subjetiva, con múltiples dimensiones: la física, la emocional, la sensorial, la social y, la psicológica. Es por ello que el abordaje de su evaluación debe tener en cuenta todos estos factores *(Figura 1)*.

Los avances en el conocimiento del dolor y la comprensión de sus múltiples componentes han dado lugar al desarrollo de gran variedad métodos de medición de este. Todos ellos apoyados en una entrevista clínica que establece las bases de la relación médico-paciente, esencial en el abordaje diagnóstico y terapéutico del dolor.

Los métodos de evaluación son mayoritariamente subjetivos, dadas las connotaciones del dolor tanto agudo como crónico, pero se apoyan en medidas físicas y objetivas aportadas por la exploración y evaluación del clínico.

A continuación, se establecen las bases de la entrevista clínica con el paciente con dolor crónico y se presentan las principales herramientas de evaluación del dolor crónico y agudo postoperatorio.

Entrevista clínica para la valoración del dolor

Como se ha anotado hasta el momento, el dolor es una experiencia con un alto componente emocional y afectivo. La percepción del dolor es subjetiva y tiene una amplísima variabilidad entre los pacientes que lo padecen. Este aspecto hace que la comunicación del médico-paciente, vehiculizada a través de la entrevista clínica, sea un punto esencial en el proceso de evaluación del paciente con dolor agudo o crónico.

Tras la entrevista clínica se debe haber establecido una relación médico-paciente adecuada, obtenido información necesaria para poder clasificar el dolor que sufre el paciente, haber podido establecer un enfoque diagnóstico y terapéutico del problema, haber detectado factores psicológicos y del entorno del paciente que tengan impacto en la evolución del dolor y detectar, si los hubiera, factores psicológicos y físicos de alarma asociados al dolor *(Figura 2)*.

La base para un abordaje adecuado del paciente con dolor es la relación médico-paciente. Por esta razón, establecer una relación de confianza entre ambos es fundamental, y debe ser el primer paso a llevar a cabo en la primera entrevista con el paciente.

La comunicación con el paciente con dolor tiene una serie de connotaciones específicas a tener en cuenta. Por un lado, si se aborda un paciente con dolor agudo, se encuentra habitualmente que el origen del dolor es fácil de reconocer. No obstante, el estado de ansiedad y estrés que suele acompañar al dolor agudo puede generar importantes problemas de comunicación entre médico y paciente que, en ocasiones, hace imposible la valoración sin iniciar previamente medidas terapéuticas para el control del dolor.

En el caso del paciente con dolor crónico, la situación suele ser totalmente diferente, en muchas ocasiones el desencadenante inicial del dolor ya no está presente. Se está ante un tipo de dolor conocido como patológico, los pacientes conocen a fondo el dolor que padecen desde hace mucho tiempo y sufren profundas afecciones psicológicas asociadas al dolor como depresión, desconfianza y frustración.

En estas circunstancias se hace necesario detectar y revertir la situación desde la primera entrevista clínica, mejorando el resultado en cuanto a control del dolor *(Figura 3)*.

La entrevista clínica debe ser realizada en un ambiente tranquilo, sin prisas y sin interrupciones. La información será obtenida principalmente de la persona que sufre el dolor a ser posible, aunque se valorará la información de las personas que conviven con ella, porque aportan información acerca del impacto familiar y social del dolor o de factores ambientales que pueden influir en la evolución del dolor en el paciente.

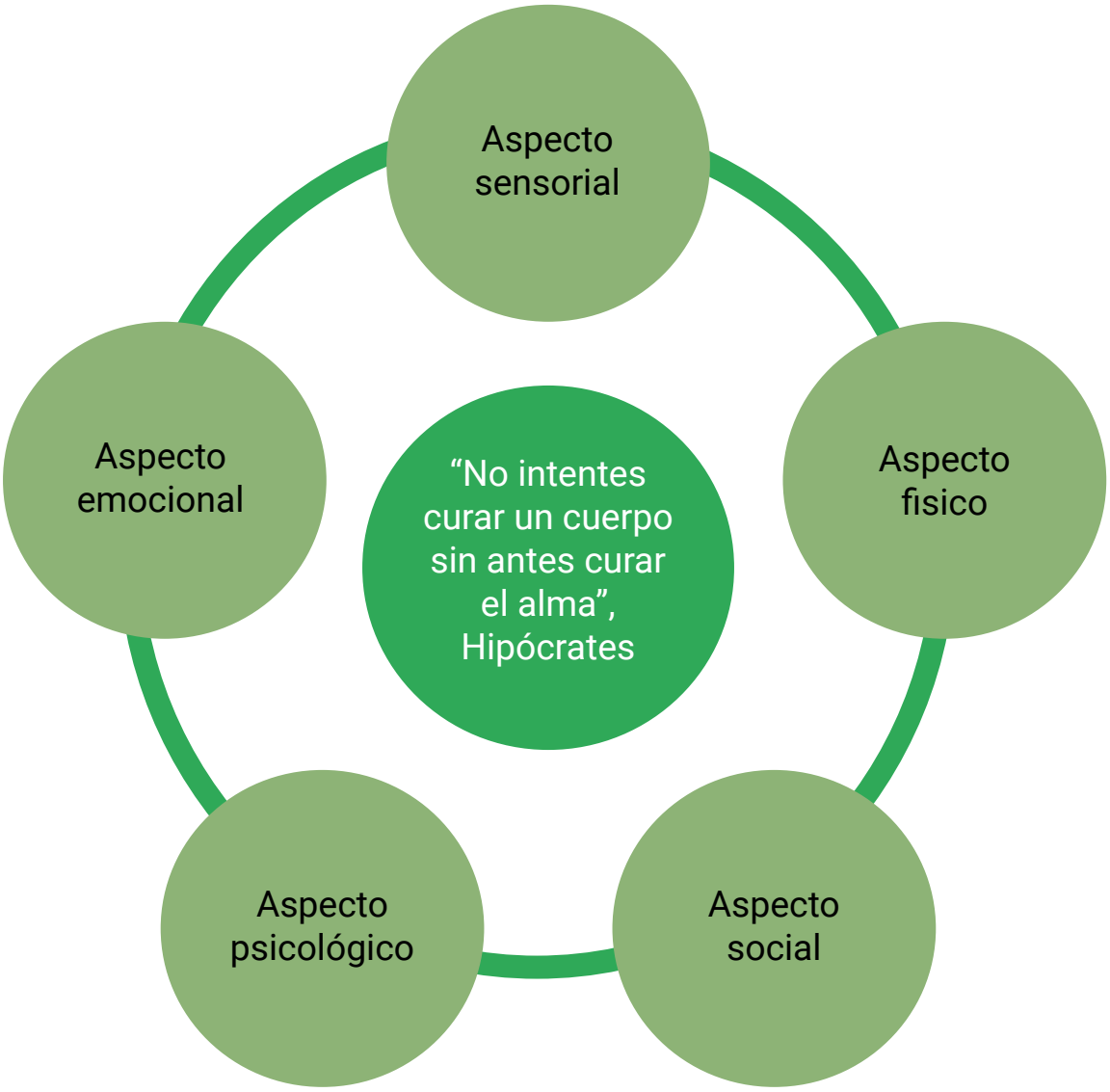


Figura 1. Multidimensionalidad del dolor.

Finalidad de la entrevista clínica

- Establecer relación de confianza médico paciente.
- Clasificación del dolor.
- Determinación de factores sociales implicados.
- Evaluación de factores psicológicos asociados.
- Establecer el enfoque diagnóstico y terapéutico.

Figura 2. Finalidades de la entrevista clínica.

Dolor agudo

- Origen del dolor fácilmente reconocible.
- Altos niveles de estrés y ansiedad interfieren en la comunicación.
- Se prioriza el control terapéutico del dolor como paso inicial.

Dolor crónico

- El desencadenante del dolor no está siempre presente.
- Profundas afecciones psicológicas.
- En muchas ocasiones desconfianza/frustración.
- Restablecer la confianza del paciente es esencial.

Figura 3. Connotaciones del dolor agudo y crónico en la entrevista clínica.

Actualmente se considera que la entrevista semiestructurada es el modelo que más se acerca a la forma ideal de evaluar el dolor. Este modelo permitirá al clínico obtener información relevante y al paciente expresarse con libertad y narrar su vivencia personal del dolor.

La entrevista médico-paciente debe tener como resultado un conocimiento del dolor y sus connotaciones físicas, emocionales y socio-familiares. Tras lo cual, el clínico debe presentar al paciente las expectativas del control de su dolor y las herramientas disponibles de forma objetiva, clara y realista.

Un aspecto fundamental es conseguir que el paciente se convierta en sujeto activo en el control del dolor que padece, ya que generalmente le ayuda a avanzar en la comprensión del dolor y participar en el proceso de tratamiento de este. Esto supone una manera útil de mejorar su aceptación y aumentar el éxito terapéutico *(Figura 4)*.

Tras la obtención de información se debe:
• Presentar las expectativas de mejoría previstas. • Explicar el plan terapéutico y herramientas disponibles en su caso. • Lograr la implicación del paciente en su proceso del control del dolor.

Figura 4. Conclusiones de la entrevista clínica.

Métodos subjetivos para la valoración del dolor

Cuando se hace referencia a la valoración del dolor, se habla de objetivar el grado de dolor, es decir, dar un valor que permita establecer un plan terapéutico proporcional al dolor que se padece. Además, una valoración del dolor permitirá cuantificar el grado de respuesta terapéutica del paciente.

Evaluar el dolor es una tarea compleja, hoy por hoy esta labor se realiza muy frecuentemente con el empleo de escalas y cuestionarios de evaluación. Con estas herramientas se pretende dirigir la observación subjetiva hacia un aspecto más definido, establecer un cuadro común de referencia para permitir una clasificación de la patología del paciente y facilitar el registro de la información, lo que será útil para establecer un diagnóstico y un plan terapéutico.

La escala y el cuestionario ideales se caracterizan por ser sencillos, fácilmente comprensibles, reproductibles, fiables y válidos en términos clínicos. Existen multitud de modelos de evaluación, numéricos, gráficos, descriptivos y conceptuales con los que se tratan de alcanzar los estándares ideales, pero todos ellos cuentan con ventajas y desventajas que se tienen en cuenta a la hora de su empleo en la práctica clínica.

Las escalas suelen tener gran aceptación por ser fácilmente comprensibles y rápidas, pero estudian el dolor de forma unidimensional valorando la intensidad del dolor principalmente, sin embargo, los cuestionarios abordan la evaluación del dolor desde el punto de vista de la subjetividad que lo define; es una experiencia sensorial que cada persona vive de forma diferente y en cada caso tiene una repercusión muy distinta a nivel físico, emocional y conductual.

Esto obliga a establecer mediciones que incluyan estos factores. Son más completos, pero suelen ser más difíciles de comprender por los pacientes y requerir más tiempo para su cumplimentación. Los métodos subjetivos para la valoración del dolor se clasifican en verbales y conductuales principalmente *(Figura 5)*.

- **Métodos verbales:**

  De alto valor en el contexto de evaluación del dolor, los métodos verbales reflejan la valoración del paciente de su dolor. Se clasifican en:

  - *Unidimensionales:* se caracterizan por la facilidad de aplicación y comprensión por parte de los pacientes. Son escalas cuantitativas o de intensidad, por lo que tienen la limitación de sólo aportar la información relativa a la intensidad del dolor y debe ser complementado por otras escalas. Tiene aplicación esencialmente en el caso de dolor agudo.

    Existen una gran cantidad de escalas, algunas de las más empleadas en la práctica clínica habitual son:

    » Escalas verbales descriptivas: los pacientes describen la intensidad del dolor catalogándolo entre leve, moderado, intenso o insoportable.

    » Escalas numéricas: se caracterizan por ser más precisas que las escalas descriptivas. El paciente establece la intensidad de su dolor en una escala numérica que suele ir de 0 a 10 o de 0 a 100. Donde 0 se corresponde con la 'ausencia total de dolor' y el número máximo de la escala se corresponde con 'dolor insoportable'. Son de fácil aplicación y además permiten valorar la respuesta al tratamiento[1].

    » Escalas visuales analógicas (EVA): ideada por Aitken[2], consiste en una línea horizontal de 10 centímetros, en cuyos extremos se encuentran las expresiones extremas del dolor como síntoma. En el izquierdo se ubica la ausencia o menor intensidad del dolor y en el derecho la mayor intensidad.

    Se pide al paciente que marque en la línea el punto que indique la intensidad y se mide con una regla milimetrada. La intensidad se expresa en centímetros o milímetros. Si el paciente puntúa el dolor por debajo de 3cm se registra dolor leve. Será dolor moderado si se puntúa entre 4 y 7cm, y severo, cuando la puntuación sea igual o superior a 8cm.

    Las EVA suelen tener menor aplicación práctica que las escalas numéricas, debido a que el concepto numérico es mucho más sencillo de entender para la mayoría de los pacientes. No obstante, la EVA es la escala que con mayor frecuencia se emplea para evaluación del dolor en investigación.

    » Escala facial de Wong-Baker: se trata de una escala que representa seis rostros que expresan desde felicidad (rostro 0) a máxima tristeza (rostro 5).

    Estas imágenes se corresponderán con el registro de diferentes intensidades de dolor donde el rostro 0 es no duele y el rostro 5 es dolor de intensidad máxima, pasando por 'duele muy poco', 'dolor perceptible' y 'dolor intenso'. Se trata de una escala que se puede utilizar desde los 3 años. Por lo que se emplea habitualmente para los pacientes en edad pediátrica *(Figura 6)*.

  - *Métodos multidimensionales:*

    Tienen la ventaja de ser más completos a la hora de aportar información, puesto que asumen la multidimensionalidad del dolor y evalúan el componente sensorial, afectivo y evolutivo del dolor. Este tipo de escalas son más efectivas para la valoración del dolor crónico.

  - *McGill Pain Questionnaire (MPQ)*[3,4] *(Figura 7):*

    El cuestionario de McGill es una de las herramientas para la evaluación del dolor más empleadas desde que fue diseñado, en 1975. Incluye 20 subcategorías compuestas con un total de 78 ítems que abordan aspectos sensorial, afectivo y evaluativo. Además, cada uno de los ítems incluye una variable que permite el registro de la intensidad.

    El cuestionario presenta varias partes bien diferenciadas, localización del dolor, cualidad del dolor, intensidad del dolor y valoración del dolor en el momento actual. El paciente irá escogiendo los adjetivos de cada una de las subcategorías, todos ellos se corresponden con un valor numérico.

    Además, permite obtener varios valores numéricos como el 'Índice de valoración del dolor', que es el resultado de la suma de cada grupo de palabras que forman cada categoría, el número de palabras elegido, suma del número de características del dolor seleccionadas por el paciente o el 'Índice de intensidad del dolor respuesta' seleccionada del ítem que explora este aspecto.

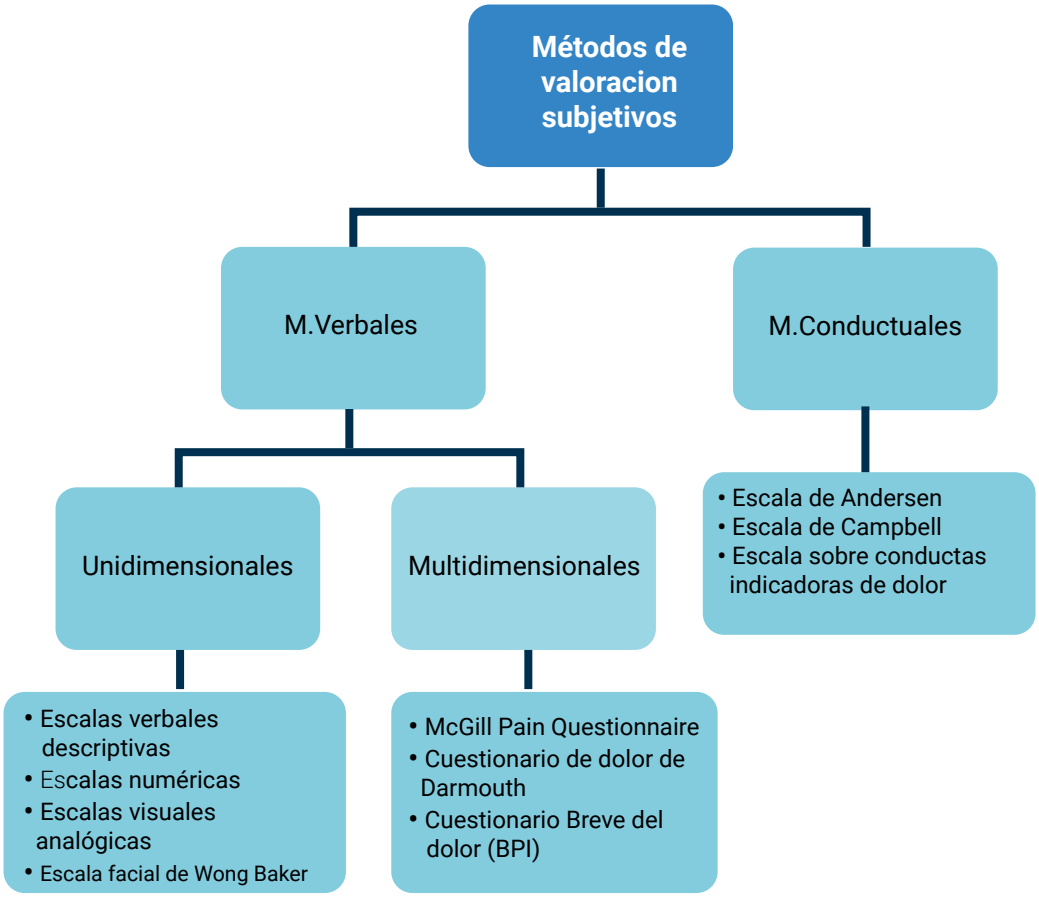


Figura 5. Clasificación de métodos subjetivos de medición del dolor.

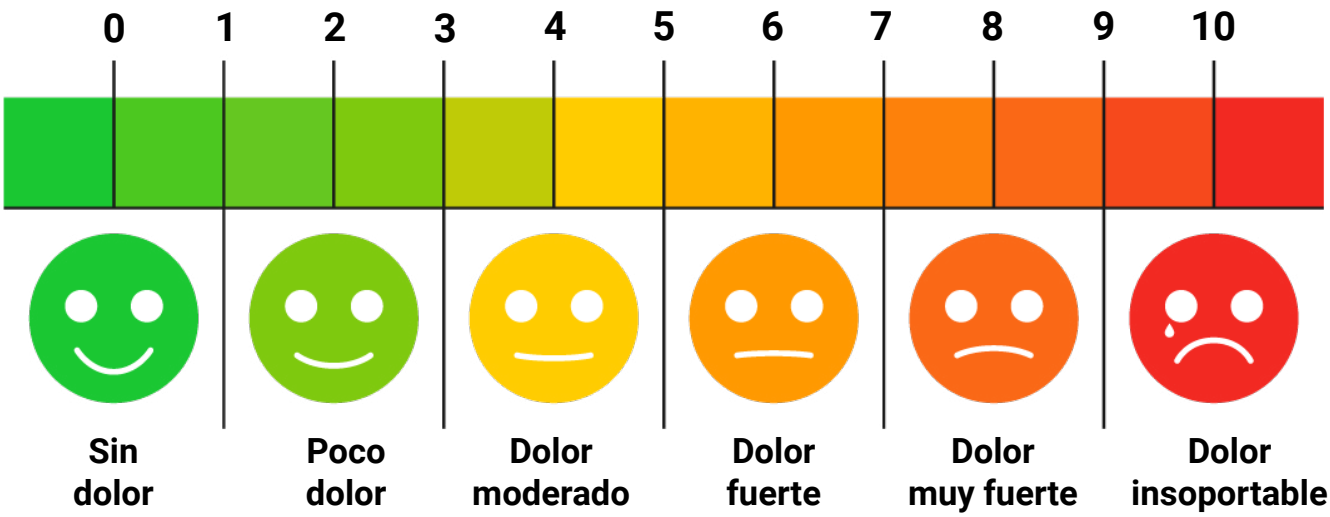


Figura 6. Escalas de valoración del dolor.

Patient's Name _____ Date _____ Time _____ am/pm

PRI: S _____ (1-10) A _____ (11-15) E _____ (16) M _____ (17-20) PRI(T) _____ (1-20) PPI _____

1 FLICKERING ___
QUIVERING ___
PULSING ___
THROBBING ___
BEATING ___
POUNDING ___

2 JUMPING ___
FLASHING ___
SHOOTING ___

3 PRICKING ___
BORING ___
DRILLING ___
STABBING ___
LANCINATING ___

4 SHARP ___
CUTTING ___
LACERATING ___

5 PINCHING ___
PRESSING ___
GNAWING ___
CRAMPING ___
CRUSHING ___

6 TUGGING ___
PULLING ___
WRENCHING ___

7 HOT ___
BURNING ___
SCALDING ___
SEARING ___

8 TINGLING ___
ITCHY ___
SMARTING ___
STINGING ___

9 DULL ___
SORE ___
HURTING ___
ACHING ___
HEAVY ___

10 TENDER ___
TAUT ___
RASPING ___
SPLITTING ___

11 TIRING ___
EXHAUSTING ___

12 SCKENING ___
SUFFOCATING ___

13 FEARFUL ___
FRIGHTFUL ___
TERRIFYING ___

14 PUNISHING ___
GRUELLING ___
CRUEL ___
VICIOUS ___
KILLING ___

15 WRETCHED ___
BLINDING ___

16 ANNCYING ___
TROUBLESOME ___
MISERABLE ___
INTENSE ___
UNBEARABLE ___

17 SPREADING ___
RADIATING ___
PENETRATING ___
PIERCING ___

18 TIGHT ___
NUMB ___
DRAWING ___
SQUEEZING ___
TEARING ___

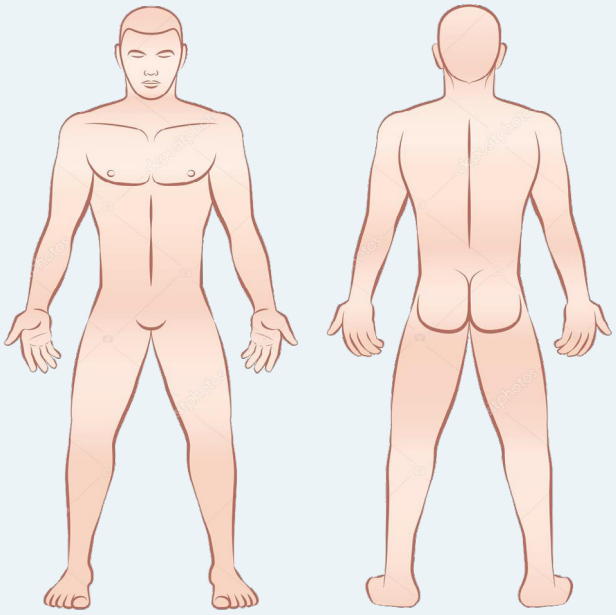
19 COOL ___
COLD ___
FREEZING ___

20 NAGGING ___
NAUSEATING ___
AGONIZING ___
DREADFUL ___
TORTURING ___

PPI

0 NO PAIN ___
1 MILD ___
2 DISCOMFORTING ___
3 DISTRESSING ___
4 HORRIBLE ___
5 EXCRUCIATING ___

BRIEF	RHYTHMIC	CONTINUOUS
MOMENTARY	PERIODIC	STEADY
TRANSIENT	INTERMTTENT	CONSTANT



E= EXTERNAL
I= INTERNAL

COMMENTS:

Figura 7. MacGill Pain Questionaire. 1975.

El cuestionario, sin embargo, presenta ciertas limitaciones, algunos pacientes tienen dificultades para su comprensión, en ocasiones resulta ambiguo y la variabilidad del número y rango de los ítems genera dudas acerca de la validez del resultado de la puntuación.

Otro de los inconvenientes es el tiempo que requiere para su cumplimentación, lo que dio lugar al desarrollo de una nueva versión reducida en 1987[5]. Con todo, el cuestionario es ampliamente aceptado para la evaluación del dolor y ha sido validado para múltiples idiomas, incluido el español[6,7].

- *Cuestionario de dolor de Dartmouth:*

  Es una variación del cuestionario de McGill que incluye dos nuevas variables: el 'Índice de autoestimación de la percepción dolorosa' y el "grado de funcionalismo o de actividades que desarrolla el paciente a pesar del dolor".

- *Cuestionario del dolor en español (CDE):*

  Se trata de un cuestionario con grandes similitudes con el *McGill Pain Questionnaire,* puesto que la metodología del desarrollo es muy similar y persigue los mismos objetivos. Incluye 62 adjetivos clasificados en 15 subclases que exploran las dimensiones sensorial, afectiva y evaluativa.

  Además, añade una escala visual analógica (EVA) y la representación de una figura humana para facilitar la localización del dolor. Con este cuestionario se obtienen tres resultados numéricos, el valor de intensidad total, el valor de intensidad actual y el valor de escala EVA.

- *Cuestionario breve del dolor (BPI)*[7,8]:

  Se trata de un cuestionario empleado de manera habitual en el ámbito de la investigación. Inicialmente se diseñó para pacientes con dolor oncológico pero su uso se ha extendido a otros tipos de dolor.

  Este cuestionario aborda la evaluación de dos dimensiones del dolor: la intensidad y la interferencia de dolor en la actividad del paciente. Además, incluye cuestiones que permiten valorar la respuesta al tratamiento y determinar la causa y la localización del dolor *(Figura 8).*

- **Método conductual:**

  Cuando se habla de método conductual para la valoración del dolor se basa en el registro y evaluación de comportamientos de muy diversa índole que el paciente manifiesta consciente o inconscientemente[9] cuando sufre dolor o que el observador, entrenado para ello, interpreta como resultado de padecer dolor. La metodología conductual se basa en la observación de una persona del entorno del paciente.

  Las conductas asociadas al dolor pueden ser muy diversas, una de sus clasificaciones clásicas es la de Fordyce[10] que incluye conductas no verbales, verbales, demanda de ayuda y signos de restricción de movimiento.

  Existen muchas escalas para la valoración conductual, pueden emplearse para complementar la información obtenida de otros modelos de evaluación, pero su empleo fundamental es en aquellos casos en los que existe dificultad para la comunicación con el paciente o para la comprensión de los métodos verbales *(Tabla 1).*

  Entre estos métodos están:

  - Escala de Andersen:

    Se trata de una escala empleada en aquellos casos en los que el paciente no puede comunicarse y es un observador externo el que la cumplimenta.

    Una de las peculiaridades de esta escala es que evalúa la intensidad del dolor, pero incluye la variable de la movilidad como factor desencadenante o agravante del dolor. Esta escala valora el dolor desde el punto de vista dinámico.

    Es útil para la valoración del dolor agudo. Las puntuaciones son:

    » 0 = No dolor.

    » 1 = No dolor en reposo y ligero a la movilización o tos.

    » 2 = Dolor ligero en reposo o moderado a la movilización o tos.

    » 3 = Dolor moderado en reposo o intenso a la movilización o tos.

    » 4 = Dolor intenso en reposo y extremo a la movilización o tos.

    » 5 = Dolor muy intenso en reposo.

    Son muy empleados en la evaluación del dolor en el paciente anciano las siguientes escalas: *The disconfort scale* (DS-DAT)[11] y *The pain assessment in advanced dementia* (PAINAD)[12], ambas incluyen aspectos relacionados con la respiración, vocalización negativa, expresión facial, lenguaje corporal y capacidad de alivio.

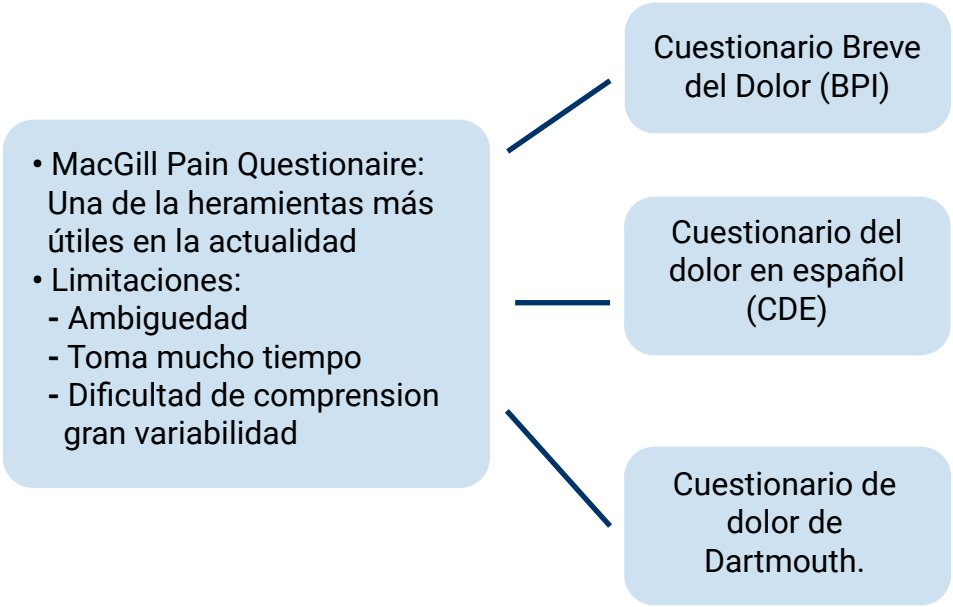


Figura 8. Métodos verbales multidimensionales.

Escalas de valoración dolor. Método conductual	
Escala de Andersen	Empleada cuando el paciente no puede comunicarse
• The disconfort scale (DS-DAT) • The pain assessment in advanced dementia (PAINAD)	Paciente anciano
CHEOPS	GOLD Standar en paciente prescolar
Escala del llanto	Paciente pediátrico
• Escala de Campbell • Escala sobre conductas indicadoras de dolor	Paciente crítico

Tabla 1. Escalas de valoración dolor. Método conductual.

En el niño, en aquellos casos en los que es imposible la comunicación oral, como en los menores de 3-4 años, se emplean las escalas conductuales, por ejemplo, la de CHEOPS[13], considerada gold estándar en pacientes pediátricos preescolares y que valora seis parámetros, el llanto/grito, expresión del rostro, verbalización, actitud corporal, deseo de tocar la herida y la posición de los miembros inferiores. Existen otras escalas válidas como la escala del llanto[14].

- *Escala de Campbell:* se trata de una escala no validada que se basa en cinco parámetros tales como la musculatura facial, la tranquilidad, el tono muscular, respuesta verbal y la confortabilidad[15]. Podría tener aplicación el paciente con patología muy grave que no tiene capacidad de comunicación. Además, son poco utilizadas, debido a que no ha sido aún validada.
- *Escala sobre conductas indicadoras de dolor:* se basa en la escala de Campbell añadiendo la adaptabilidad a la ventilación mecánica. Además, es desarrollada para la valoración del dolor en el paciente en unidades de cuidados críticos, pero aún requiere validación[16,17].

Valoración basada en parámetros fisiológicos

La valoración de parámetros fisiológicos se considera una forma objetiva de evaluación del dolor. Establecer una correlación entre parámetros fisiológicos y dolor, podría tener un impacto muy favorable en la medición de procesos dolorosos. No obstante, hasta la fecha, los resultados de las investigaciones en este sentido no han sido satisfactorias y los métodos físicos son poco empleados.

Algunos de los parámetros estudiados hasta la fecha son:

- **Indicadores de respuesta del sistema nervioso autónomo al dolor:**

  Datos clínicos objetivos como la tensión arterial, la frecuencia cardiaca, la sudoración y lagrimeo son fácilmente registrables, se emplean como referencia para la valoración del dolor intraoperatorio y para la evaluación de su respuesta a tratamiento analgésico.

La termografía, por su parte, es un tipo de monitorización objetiva que, pese a no ser una medida del dolor propiamente dicho, sí puede tener un valor a la hora de detectar fases precoces en síndromes dolorosos como el síndrome regional complejo, que se asocia a un patrón de hipertermia o síndromes reumáticos o vasculares.

También se puede emplear para la monitorización de la evolución de estos síndromes y la respuesta al tratamiento que está asociada con el grado de dolor referido.

- **Determinaciones bioquímicas:**

  Se ha tratado de establecer una correlación entre los niveles séricos de catecolaminas, cortisol u hormona antidiurética con el grado de dolor, debido a la estimulación del eje neuroendocrino.

  Sin embargo, hasta el momento los resultados no han sido satisfactorios y no se han podido desarrollar métodos de valoración de dolor efectivos con estos parámetros.

  Estudios neurofisiológicos, habitualmente empleados en el estudio de patologías neurológicas periféricas, incluyen la electromiografía, el registro de actividad eléctrica en nervios periféricos y los potenciales evocados.

  En cuanto a estos últimos, parece existir una correlación entre la intensidad de los estímulos nociceptivos y la amplitud de las ondas cerebrales; la amplitud de onda es menor tras la administración de analgésicos.

  Las pruebas neurofisiológicas no han demostrado ser muy útiles por el momento, especialmente a nivel central, y a menudo no se correlaciona el grado de lesión histológica por las pruebas complementarias con la percepción subjetiva de dolor por parte del paciente *(Figura 9)*.

  La tomografía de emisión de positrones (PET) por su parte parece evidenciar un aumento de flujos sanguíneos y consumo de oxígeno asociados al dolor, lo que le confiere un cierto valor como prueba diagnóstica para el Sistema Nervioso Central *(Figura 10)*.

- **Valoración del dolor crónico:**

  La variabilidad de las características de los grandes síndromes dolorosos crónicos han tenido como consecuencia el desarrollo de diferentes métodos de medición del dolor en función del tipo de patología.

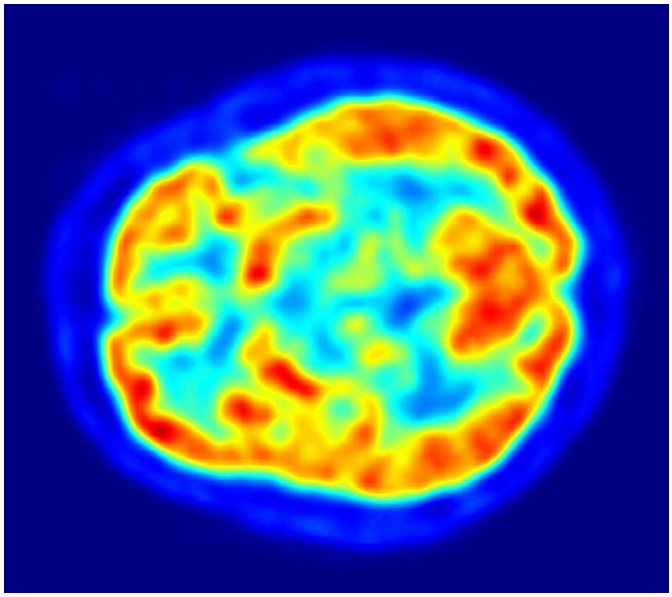


Figura 9. Imagen típica de PET. Jens Maus (s.f.)

A continuación, se aborda la evaluación del dolor en dos de las entidades clínicas de mayor peso cuando se habla del dolor crónico.

- *Evaluación del dolor oncológico:*

  En la evaluación del dolor oncológico se deben tener en cuenta varios aspectos:

  » Medición de intensidad del dolor, para lo que se suelen utilizar algunas de las escalas unidimensionales, eligiéndolas en función de las características del paciente.

  » Evaluación del tipo de dolor, el dolor oncológico puede ser somático, visceral neuropático o mixto; se emplean las escalas de dolor adecuadas para cada uno de ellos.

  » Patrón de dolor, evaluando la duración, el comienzo y la persistencia de éste.

  » Factores desencadenantes, agravantes y de alivio.

  » Efectos sobre la vida cotidiana.

  Para el aspecto multidimensional que tiene el dolor oncológico se suelen emplear las escalas más habituales el cuestionario de McGill-Melzack (MPQ, McGIll Pain Questionaire), el test de Latineen[18] y el Wisconsin Brief Pain Questionnaire o Brief Pain Inventory [BPI] (Cuestionario breve del dolor)[19].

- *Evaluación del dolor neuropático:*

  Se trata de un síndrome doloroso con una altísima complejidad, lo que dificulta enormemente su definición y clasificación como síndrome clínico. Esto provoca que la evaluación del dolor neuropático sea especialmente compleja.

  Actualmente se recomienda que la evaluación del dolor neuropático esté basada en una exhaustiva historia clínica que permita determinar el dolor en términos de temporalidad, localización, duración y periodicidad, intensidad y sintomatología sensitiva acompañante.

Figura 10. Métodos fisiológicos para valoración del dolor.

Se acepta el empleo de las escalas unidimensionales para evaluación de la intensidad del dolor, pero siempre deben ser complementadas por otras herramientas que puedan abordar las demás dimensiones de este dolor, dada la gran complejidad de este[20].

Se cuenta con diferentes métodos de medición específicos para este tipo de dolor como la Neuropathic *Pain Scale (NPS) y Neuropathic Pain Syntom Inventory (NPSI),* son escalas útiles para el diagnóstico diferencial, medición de intensidad y evaluación del tratamiento en el dolor neuropático[21,22].

La *LANSS Pain Scale (Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs):* se trata de un cuestionario que incluye datos derivados de la exploración del déficit sensorial y de la descripción del dolor por parte del paciente. Es una de las más utilizadas en la práctica clínica.

Y *la Neuropathic Pain Diagnostic Questionnaire (DN4),* cuestionario que incluye un componente subjetivo descriptivo y un componente objetivo derivado de la exploración del clínico, se caracteriza porque puede ser empleada para la evaluación de dolor neuropático y también somático[23] *(Figura 11).*

- **Valoración del dolor agudo postoperatorio** *(Tabla 2).*

  El dolor agudo postoperatorio es una de las principales complicaciones perioperatorias. El paciente suele presentar niveles altos de preocupación por el dolor cuando se enfrentan a un procedimiento quirúrgico[24].

  Por otro lado, es un problema institucional porque hasta un 75% de los pacientes intervenidos sufren dolor moderado o intenso lo que tiene un impacto negativo en la morbilidad y supone un aumento del gasto hospitalario[25].

  Además, el mal control del dolor agudo postoperatorio se asocia a incremento de la incidencia de dolor crónico tras la intervención. (26) Estos aspectos hacen esencial que se deba medir el dolor postoperatorio para abordarlo de forma exitosa.

  El adecuado control del dolor postoperatorio requiere de una evaluación de éste, objetiva y periódica. Hasta el momento se recomienda el empleo de escalas unidimensionales para la evaluación del dolor agudo postoperatorio.

  La escala ideal para la medición del dolor agudo postoperatorio se caracteriza por su aplicabilidad, fiabilidad, validez, versatilidad, uniformidad, idoneidad y sensibilidad.

Evaluación D. Oncológico

- Intensidad del dolor.
- Tipo de dolor.
- Patrón del dolor.
- **Factores de influencia:** desencadentantes, agravantes y alivio.
- Efectos sobre la vida cotidiana.
- McGill Pain Questionaire, Test de Latineen y Brief Pain Inventory.

Evaluación D. Neuropático

- Localización.
- Temporalidad.
- Duración.
- Perioricidad.
- Intensidad.
- **Alteraciones:** sensitivas/troficas.
- Neuropathic Pain Scale , Neuropathic Pain Syntom Inventory, LANSS Pain Scale y Neuropathic Pain Diagnostic Questionnaire.

Figura 11. Evaluación de grandes síndromes del dolor crónico.

Claves para la valoración del dolor agudo postoperatorio (DAP)
Evaluación objetiva y periódica
Evaluar en DAP en sus tres fases: • Reposo • Movimiento • Postestimulación
Escalas verbales unidimensionales: numéricas
Escalas verbales multidimensionales: cuestionario de dolor de McGill
Escalas conductuales: escala de Andersen
Parámetros fisiológicos: TA, FC, patrones ventilatorios
Se da la premisa de combinar parámetros subjetivos y objetivos

Tabla 2. Claves en la valoración del dolor agudo post-operatorio.

De entre las escalas disponibles, las escalas numéricas suelen ser mejor aceptadas por los pacientes y por el personal sanitario. Estas escalas se pueden emplear asimismo para evaluar la respuesta al tratamiento analgésico.

Las escalas conductuales son empleadas también, pero se reservan para casos en las que el paciente no puede comprender las escalas numéricas o no puede comunicarse como el caso de niños menores de 5 años o personas con déficits cognitivos severos.

En el marco del dolor agudo postoperatorio se ha aplicado con éxito la escala de Andersen, porque es capaz de evaluar el dolor desde el punto de vista dinámico y se correlaciona bien con otras escalas de dolor.

Sin embargo, actualmente se considera que el dolor agudo postoperatorio también debería ser enfocado desde el punto de vista multidimensional.

La experiencia del empleo de métodos multidimensionales en el dolor agudo postoperatorio es muy limitada, sin embargo, el cuestionario de dolor de McGill parece tener utilidad en la valoración de protocolos analgésicos en procedimientos quirúrgicos[27,28].

Pese que a la validez de los parámetros objetivos fisiológicos no ha sido demostrada; es en el contexto de dolor agudo postoperatorio donde se tienen en cuenta factores como la hipertensión, frecuencia cardíaca, náuseas y sudoración como marcadores asociados a la presencia del dolor e indicadores de respuesta a tratamiento.

También parece existir una correlación entre la modificación de volúmenes ventilatorios y la intensidad del dolor, sobre todo en cirugía torácica y abdominal. No obstante, estos marcadores se tienen en cuenta sólo como valor complementario a los anteriores, ya que pueden verse modificados por otros muchos factores.

En la actualidad, en la valoración y abordaje del dolor postoperatorio se aconseja el empleo de la información obtenida de métodos subjetivos y objetivos para la valoración, a pesar de que los resultados obtenidos de las diferentes observaciones pueden ser contradictorios.

No se debe olvidar la relevancia de evaluar el dolor, clasificándolo en tres fases: el dolor en reposo, que hasta ahora ha sido el dolor que se ha valorado preferentemente tras una intervención, el dolor en movimiento, un tipo de dolor irruptivo, relacionado con un estímulo desencadenante y que cede mal con opioides, y el dolor postestimulación, que se asocia a fenómenos de alodinia y de hiperalgesia en áreas periféricas a la herida quirúrgica y cuya evaluación, en cuanto a intensidad y extensión, es importante debido a que puede predecir fenómenos de cronificación del dolor agudo postoperatorio.

Aspectos multidisciplinares de la valoración del dolor

Desde el punto de vista de la evaluación multidisciplinar del dolor, hoy por hoy no se concibe que, en la valoración del dolor, sobre todo en el dolor crónico pero cada vez más en el dolor agudo, no se incorpore el concepto de la dimensión emocional del dolor.

Para ello, es indispensable la valoración psicopatológica del paciente con dolor. Los aspectos psicológicos y emocionales de los pacientes tienen un efecto modulador en la evolución del dolor en el paciente, pudiendo tener un efecto positivo o negativo según el caso.

Este tipo de valoración es subjetiva casi en el 100% de los casos, existen múltiples modelos de cuestionarios y autorregistros que tratan de explorar esta dimensión de dolor, entre ellos los más destacables son:

- **West Haven-Yale Multidimensional Inventory (WHYMPI):** (29,30) es un cuestionario ampliamente aceptado en la actualidad y tiene como ventaja que aborda la evaluación del dolor desde una base teórica cognitivo-conductual. Se trata de un cuestionario de fácil respuesta por parte del paciente y que se adapta a múltiples niveles socioculturales *(Tabla 3)*.
- **Cuestionario de afrontamiento del dolor crónico:** inicialmente incluyen 31 ítems, recoge seis factores: autoafirmación, búsqueda de información, religión, distracción, catarsis y autocontrol mental. Su versión reducida con 24 ítems, incluye la evaluación del concepto de afrontamiento del dolor crónico. Este aspecto es relevante, puesto que las conductas de afrontamiento actúan como moduladoras del componente emocional del dolor, pudiendo favorecer la adaptación o desadaptación del paciente a su situación clínica.

Pruebas dirigidas a conocer aspectos psicológicos y psicopatológicos de la personalidad de los pacientes:

- **Cuestionario de Personalidad de Eynsenck-Revisado (31) (EPQ-R):** evalúa las tres dimensiones básicas de la personalidad: extraversión, neuroticismo y psicoticismo, junto con una escala complementaria de disimulo que permite medir la deseabilidad social.
- **Listado de Síntomas Breve (LSB-50)[32]:** consta de 50 ítems y está compuesto por siete escalas principales (psicorreactividad, hipersensibilidad, obsesión-compulsión, ansiedad, hostilidad, somatización y depresión), dos subescalas (alteraciones del sueño y alteraciones del sueño ampliada) y una escala de riesgo psicopatológico.
- **El Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)[33]:** es una herramienta que ha demostrado validez en pacientes ingresados con patología medico quirúrgica aguda: consta de 14 ítems y la intensidad o frecuencia del síntoma se evalúa en una escala de Lickert de 4 puntos.

  Es una herramienta útil para determinar la presencia de ansiedad o depresión en pacientes ingresados. A efectos prácticos permite valorar cambios en la evaluación de la enfermedad en el paciente y la respuesta a intervenciones terapéuticas.

Factor loading	Inventory item
Scale 1: household chore	
• 0.79	• Prepare a meal
• 0.78	• Help with house cleaning
• 0.70	• Wash dishes
• 0.69	• Do laundry
• 0.66	• Go grocery shopping
Scale 2: outdoor work	
• 0.68	• Work on house repairs
• 0.65	• Wash the car
• 0.64	• Mow the lawn
• 0.59	• Work on the car
• 0.50	• Work in the garden
Scale 3: activities away from home	
• 0.59	• Take a trip
• 0.52	• Go out to eat
• 0.51	• Go to a movie
• 0.48	• Take a ride in the car
Scale 4: social activities	
• 0.70	• Visit relatives
• 0.51	• Visit firends
• 0.46	• Go to the parl or beach
• 0.44	• Play cards or other games

Tabla 3. West Haven-Yale Multidimensional Inventory (WHYMPI). Kerns (1985).

Bibliografía

1. Downie WW, Leatham PA, Rhind VM, Wright V, Branco JA, Anderson JA Studies with pain rating scales. Ann Rheum Dis. 1978 Aug;37(4):378-81.
2. R. C. Aitken. Measurement of feelings using visual analogue scales. Proc R Soc Med. 1969 Oct; 62(10): 989–993.
3. Melzack R. The McGlll Pain Questionnalre: Major properties and scoring methods. Pain 1975; 1: 277-99.
4. Lázaro C, Bosch F, Torrubia R, et al. The development of a Spanish Questionnaire for assesing pain: preliminary data concerning reliability and validity. Eur J Psychol Assessment 1994; 10: 141-51.
5. Melzack R. The short-form McGill pain questionnaire. 1987;30(2):191-197.
6. Masedo AI, Esteve R. Some empirical evidence regarding the validity of the Spanish version of the McGill Pain Questionnaire (MPQ-SV). Pain. 2000 Apr;85(3):451-61.
7. Badia X, Muriel C. Validación española del cuestionario Brief Pain Inventory en pacientes con dolor de causa neoplásica. Medicina Clínica 2003;120(2): 52-59 14.
8. De Andrés Ares J1, Cruces Prado LM2.Validation of the Short Form of the Brief Pain Inventory (BPI-SF) in Spanish Patients with Non-Cancer-Related Pain. Pain Pract. 2015 Sep;15(7):643-53.
9. Labus JS, Keefe FJ, Jensen MP. Self-reports of pain intensity and direct observations of pain behavior: whenare they correlated? Pain,2003; 102:109-124.
10. Fordyce. W.E. (1976). Behavioral method for chronic pain and illness, San Luis. Mosby.
11. The Discomfort Behavior Scale: a measure of discomfort in the cognitively impaired based on the Minimum Data Set 2.0. Stevenson KM, Brown RL, Dahl JL, Ward SE, Brown MS. Res Nurs Health. 2006 Dec;29(6):576-87.

12. Warden V, Hurley AC, L Volicer Development and Psychometric Evaluation of the Pain Assessment inAdvanced Dementia (PAINAD) Scale. Am Med Dir Assoc 2003; 4: 9–15.
13. McGrath PJ, Johnston G, Goodman JT. CHEOPS: a behavioral scale for rating postoperative pain in children. Advances in Pain Research and Therapy, pp. 395-402.
14. Reinoso-Barbero F. Lahoz Ramón AI, Durán Fuente MP, Campo García G, Castro Parga LE. Escala llanto: instrumento español de medición del dolor agudo en la edad preescolar. An Pediatr (Barc). 2011;74(1):10—14.
15. Erdek MA, Pronovost PJ. Improving assessment and treatment of pain in the critically ill. Int J Qual Health Care. 2004;16: 59-64.
16. Latorre Marco I, Solís Muñoz M, Falero Ruiz T, et al. Validación de la Escala de Conductas Indicadoras de dolor para valorar el dolor en pacientes críticos, no comunicativos y sometidos a ventilación mecánica: resultados del proyecto ESCID. Enferm Intensiva. 2011;22(1):3-12.
17. Gélinas C, Fortier M, Viens C, Fillion L, Puntillo K. Pain Assessment and Management in Critically Ill Intubated Patients: a Retrospective Study. Am J Crit Care. 2004;13:126-136.
18. Caraceni A, Brunelli C, Martini C y cols. Cancer pain assessment in clinical trials. A review of the literature (1999-2002). J Pain Symptom Manage, 2005; 29: 507-519.
19. Monsalve V, Soriano J, Andrés JD. Utilidad del Índice de Lattinen (IL) en la evaluación del dolor crónico: relaciones con afrontamiento y calidad de vida. Revista de la Sociedad Española del Dolor. 2006; 13(4): 216-29.
20. Guevara-López U, Covarrubias-Gómez A, Rodríguez-Cabrera R, Carrasco-Rojas A, Aragón G, Ayón-Villanueva H. Parámetros de práctica para el manejo del dolor neuropático. Rev Invest Clin 2006; 58 (2): 126-138.
21. Fishbain DA1, Lewis JE,Can the neuropathic pain scale discriminate between non-neuropathic and neuropathic pain? Pain Med. 2008 Mar;9(2):149-60.
22. Villoria J1, Rodríguez M Psychometric validation of the neuropathic pain symptom inventory for its use in Spanish. J Pain Symptom Manage. 2011 Jul;42(1):134-46.
23. Pérez C, Galvez R. Validity and reliability of the Spanish version of the DN4 (Douleur Neuropathique 4 questions) questionnaire for differential diagnosis of pain syndromes associated to a neuropathic or somatic component. Health Qual Life Outcomes. 2007 Dec 4;5:66.
24. Zaslansky R, Rothaug J, Chapman CR, Bäckström R, Brill S, Fletcher D, et al. Pain out: the making of an international acute pain registry. Eur J Pain 2015 Apr;19(4):490-502.
25. Rawal N. Current issues in postoperative pain management. Eur J Anaesthesiol 2016 Mar;33(3):160-71.
26. Gewandter JS, Dworkin RH, Turk DC, Farrar JT, Fillingim RB, Gilron I. Research design considerations for chronic pain prevention clinical trials: IMMPACT recommendations. Pain 2015 Jul;156(7):1184-97.
27. Cayao Flores, Ana Lucia; Changa Murga RC. Validación de un instrumento de valoración del dolor severo en pacientes escolares postoperados del Servicio de Ortopedia y Traumatología del INSN [Internet]. Universidad Cayetano Heredia (Lima, Perú); 2017. Disponible en:https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/1345/Validacion_CayaoFlores_Ana.pdf?sequence=1&isAllowed=y
28. Aznar OM. Evaluación de la eficacia analgésica de protocolos de dolor agudo postoperatorio. Rev. Soc. Esp. Dolor. 2010.1:5-48.
29. Kerns, R.D., Turk, D.C., & Rudy, T.E. The West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory (WHYMPI). Pain 1985; 23: 345-356.
30. Ferrer, V.A., González, R. y Manassero, M.A. (1993). El West Haven Yale Multidimensional Pain Questionnaire: Un instrumento para evaluar al paciente con dolor crónico. Dolor: Investigación, Clínica y Terapeútica, 8, 153-160.
31. Eysenck, HJ, Eysenck, SBG (2001). Cuestionario revisado de personalidad de Eysenck: versiones completa (EPQ-R) y abreviada (EPQ-RS) [Eysenck Personality Questionnaire Revised: Full Version (EPQ-R) and Short (EPQ-RS)]. TEA: Madrid.
32. De Rivera, L. & Abuín, M. R. (2012). LSB–50, Listado de Síntomas Breve. Madrid: TEA Ediciones.
33. Zigmond, AS; Snaith, RP (1983). "The hospital anxiety and depression scale". Acta Psychiatrica Scandinavica. 67 (6): 361–370.